

2) 肺炎・細菌性気管支炎：原因菌に応じた抗菌薬を投与する。

b 慢性咳嗽の治療

1) 咳喘息：吸入ステロイド薬（ICS）＋短時間作用性 β_2 刺激薬（SABA）

2) GERD：プロトンポンプ阻害薬（PPI）を投与し、生活習慣改善を指導する。

3) アトピー咳嗽：抗ヒスタミン薬

4) 薬剤性咳嗽：原因薬剤の中止を行う。

5) 難治性慢性咳嗽：神経調節薬（gabapentin, pregabalin）、P2X3 受容体拮抗薬（gefapixant）

c 補助療法・リハビリテーション

1) 呼吸リハビリテーション：慢性咳嗽に対する呼吸法指導や咳嗽抑制トレーニングを実施する。特に COPD や

間質性肺炎の患者では、気道クリアランスの向上や呼吸筋の強化が有用である。

2) 水分摂取・加湿：気道粘膜を保護し、喀痰の排出を促進する。

3) 禁煙指導：喫煙は咳嗽の増悪因子であり、禁煙が推奨される。

文 献

- 1) 日本呼吸器学会咳嗽・喀痰の診療ガイドライン第2版
作成委員会（編）：咳嗽・喀痰の診療ガイドライン
2025，メディカルレビュー社，2025
- 2) Hegland KW, et al : J Appl Physiol **112** : 1493, 2012
- 3) Chung KF : Nat Rev Dis Primers **8** : 45, 2022
- 4) Smithard DG : Therapy **3** : 291, 2006